

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Standard Dehydration	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: alle

Definition:

- Der menschliche Körper besteht zu 50 bis 60 Prozent aus Wasser. Durch Miktion (Wasserlassen), Defäkation (Stuhlentleerung), Emesis (Erbrechen), Transpiration (Schweiß) und Respiration (Atmung) verliert ein Mensch jeden Tag eine beträchtliche Wassermenge, die durch Flüssigkeitsaufnahme kompensiert werden muss. Als minimale Flüssigkeitszufuhr gelten 2 Liter Wasser, von denen durchschnittlich 1,3 Liter über Getränke und 0,7 Liter über die Nahrung zugeführt werden.
- Eine andere Faustregel besagt: Ein Mensch benötigt täglich 30 ml Flüssigkeitszufuhr pro kg Körpergewicht. Berechnungsbasis ist das Körpersollgewicht.
- Wird die dem Körper entzogene Flüssigkeit nicht ersetzt, kommt es zu einem Defizit im Wasser- und Elektrolythaushalt ("Dehydratation" oder "Exsikkose"). Vor allem Senioren sind gefährdet, da deren Durstgefühl vermindert ist.

Bei einer Dehydratation werden drei Schweregrade unterschieden:

Bei einer leichten Dehydratation tritt eine mäßige Austrocknung der Schleimhäute auf. Der Achselschweiß ist vermindert. Die Urinmenge lässt nach. Der Urin ist konzentrierter.

Bei einer mäßigen Dehydratation trocknen die Schleimhäute vollständig aus. Der Spannungszustand der Haut ist reduziert. Die Harnausscheidung kommt nahezu zum Erliegen. Die Herzfrequenz steigt deutlich. Der Blutdruck sinkt. Der Patient klagt über Schwäche und Schwindel. Die Sturzneigung steigt. Der Patient ist unkonzentriert.

Bei einer schweren Dehydratation scheidet der Patient keinen Urin mehr aus. Der Puls ist schnell und fadenförmig. Der Blutdruck ist zu niedrig. Der Patient ist verwirrt.

Eine fundierte Dehydratationsprophylaxe umfasst daher zwei Komponenten: zum einen die Beobachtung des Trinkverhaltens und zum anderen die Hilfestellung beim Trinken.

Grundsätze:

- Durch prophylaktische Maßnahmen lässt sich eine Dehydrierung vermeiden.
- Ausreichendes Trinken lässt sich auch im hohen Alter noch lernen.
- Jeder Patient hat das Recht, das Getränk zu sich zu nehmen, das ihm am besten schmeckt. Sofern keine zwingenden medizinischen Diagnosen dem entgegenstehen, kann jeder Bewohner in Maßen auch alkoholische Getränke wie etwa Bier, Wein, Alster / Radler usw. zu sich nehmen.
- Kein Patient darf gegen seinen Willen zwangsweise mit Flüssigkeit versorgt oder zum Trinken genötigt werden.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Vertreiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	1/5	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Standard Dehydration	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: alle

- Ausnahmslos werden alle Maßnahmen zur Dehydratationsprophylaxe sorgfältig dokumentiert

Eine verminderte Flüssigkeitszufuhr ist kein geeignetes Mittel, um die Anzahl der Toilettengänge zu reduzieren.

Ziele:

- Der Patient erhält ausreichend Flüssigkeit. Er nimmt die individuell notwendige Wassermenge auf möglichst natürliche Art zu sich, also in Form von Getränken und von flüssigkeitshaltigen Speisen.
- Der Patient ist in der Lage, sich möglichst eigenständig mit Flüssigkeit zu versorgen.
- Eine Dehydratation wird frühzeitig festgestellt und überwunden.
- Invasive Maßnahmen, wie etwa intravenöse oder subkutane Infusionen, rektale Flüssigkeitszufuhr oder eine PEG-Sonde, werden vermieden.

Die Ursachen für die Dehydratation werden ermittelt.

Vorbereitung:

Informationssammlung

Die Ermittlung des bisherigen Trinkverhaltens ist Teil des Aufnahmegesprächs. Wenn der Patient etwa infolge einer Demenz zu klaren Antworten nicht mehr in der Lage ist, befragen wir die Angehörigen.

- Welche Getränke bevorzugte der Patient in der Vergangenheit?
- Welche Rituale und Gewohnheiten sind mit der Flüssigkeitsaufnahme verbunden?
- Äußert der Patient den Wunsch nach einem Getränk von sich aus oder muss er von anderen zum Trinken animiert werden?

Symptome

Wir achten auf Symptome, die für eine sich entwickelnde Dehydratation sprechen. Diese treten i.d.R. gebündelt auf. Die Pflegekraft sollte die Symptomatik daher im Gesamtzusammenhang betrachten. Dann ist eine Dehydratation vergleichsweise einfach zu erkennen.

- Durst, der im weiteren Verlauf einer Dehydratation aber nachlassen kann
- verringerte Speichelsekretion, verschwundener "Speichelsee" unter der Zunge
- trockene Schleimhäute, insbesondere raue, borkige Zunge und trockene Lippen
- reduzierte Urinmenge, konzentrierter und dunkler Urin
- Blutdruckabfall
- Tachykardie
- Kopfschmerzen
- Müdigkeit und Kraftlosigkeit

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Vertreiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	2/5	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Standard Dehydration	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: alle

- Mundgeruch
- Krämpfe
- Antriebslosigkeit
- Obstipation
- Magenbeschwerden und Appetitlosigkeit
- Schwindel und plötzlich auftretende Gangunsicherheit
- Verwirrtheit
- Gedächtnisstörungen
- Sprachstörungen
- plötzlicher Gewichtsverlust
- Fieber

(Hinweis zur Hautspannung bei einer bestehenden Dehydratation: Wenn die Pflegekraft eine Hautfalte bildet, bleibt diese nach dem Loslassen für einige Augenblicke stehen. Die Aussagekraft des Hautfaltentests wird häufig allerdings überbewertet. Nicht bei jedem dehydrierten Menschen bleibt die Hautfalte stehen. Zudem bleibt die Hautfalte auch bei vielen Senioren stehen, die gut mit Flüssigkeit versorgt sind.)

Ursachen und andere erschwerende Faktoren

Wir prüfen, welche Ursachen für die Dehydratation infrage kommen

- Der Patient leidet unter Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts und damit unter einem Flüssigkeitsverlust, etwa durch Erbrechen oder Durchfall
- Die Außentemperaturen sind hoch. Der Körper verliert zu viel Flüssigkeit über das Schwitzen und über die Atemluft
- Der Patient hat Fieber
- Der Patient leidet unter Erkrankungen, die zu einem Flüssigkeitsungleichgewicht führen, etwa unter Nierenerkrankungen
- Der Patient trinkt zu wenig als Folge mangelnden Durstgefühls
- Der Patient reduziert die Flüssigkeitsaufnahme, um einen unfreiwilligen Urinabgang zu verhindern
- Die Trinkmenge ist zu gering, da der Patient Harndrang in der Nacht vermeiden will
- Es liegen Lähmungen vor (Hemiplegie oder Fazialisparese)
- Der Patient leidet unter Schluckstörungen. Er trinkt zu wenig aus Angst, sich an dem Getränk zu verschlucken
- Der Patient hat zu wenig Kraft, um den Becher zu heben
- Die Handkontrolle des Patienten ist beeinträchtigt. Er hat Angst, das Getränk zu verschütten
- Die Krankheitseinsicht ist unzureichend, etwa infolge einer demenziellen Erkrankung
- Der Patient schätzt seinen Flüssigkeitsbedarf zu gering ein
- Es liegt eine Sehbehinderung vor. Der Patient kann das Trinkgefäß nicht sehen

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Vertreiber
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	3/5	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Standard Dehydration	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: alle

- Der Patient ist vergesslich. Er vergisst die Flüssigkeitsaufnahme.
- Der Patient leidet unter Vergiftungswahn
- Der Patient ist fixiert, etwa aufgrund motorischer Unruhe oder Selbstgefährdung. Er kann das Glas nicht erreichen
- Der Patient leidet unter großflächigen und nässenden Wunden.
- Es liegt eine Stoffwechselstörung vor wie etwa ein unbehandelter Diabetes mellitus
- Der Patient leidet unter einer Herzinsuffizienz. Er unterliegt einer Trinkmengenbeschränkung
- Der Patient nimmt Medikamente ein, die den Flüssigkeitshaushalt beeinflussen wie etwa entwässernde Arzneimittel
- Es liegt ein Abführmittelmissbrauch vor
- Der Hypothalamus des Patient ist geschädigt mit der Folge eines verminderten Durstgefühls.
- Der Lebenswille des Patient ist erloschen
- Angebotene Getränke schmecken ihm einfach nicht

Maßnahmen

- Jeder Patient wird über die Wichtigkeit einer angemessenen Flüssigkeitsversorgung informiert. Wir haben dafür ein **Beratungsprotokoll** (3023). Dieses wird von der Pflegekraft im Dialog mit dem Patient und seinen Angehörigen ausgefüllt. Der Patient erfährt darin, wie er einen Flüssigkeitsmangel erkennt und welche Maßnahmen er treffen kann, um das Defizit zu kompensieren. Wir erfragen auch, welche Maßnahmen der Patient ablehnt. (Hinweis: Das Protokoll sollte vom Patient oder von seinem rechtlichen Stellvertreter unterschrieben werden.)
- Wir errechnen, welche Flüssigkeitsmenge der Patient jeden Tag erhalten soll. Dieser Wert ist z.B. die Grundlage für die Erstellung eines Trinkplans, dieser wird im Maßnahmenplan eingearbeitet
- Gegebenenfalls wird der Dialog zum Arzt gesucht und Trinkmengen werden festgelegt, auf Grund von Erkrankungen wo dieses notwendig ist.

Wir legen auch gemeinsam mit Patient, AG und Hausarzt einen Schwellenwert für ein Flüssigkeitsdefizit fest, bei dessen Unterschreitung eine ergänzende Infusionstherapie angestrebt ist.

Durchführung:

Risikoermittlung

- Sofern der Verdacht besteht, dass der Patient zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt, wird das Trinkverhalten eine Woche lang gezielt beobachtet und protokolliert. Die Auswertung dieses Protokolls sollte möglichst zusammen mit dem Patient erfolgen

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	4/5	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Standard Dehydration	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: alle

Wann wird Einfuhrprotokoll (DL3115) geführt?

- Bei Neuaufnahmen und Krankenhausentlassungen
- Bei akuten Veränderungen der Zufuhrmenge
- Bei Verwirrheitszuständen
- Bei auftreten von Dehydrationsanzeichen
- Wenn sich konzentrierten Urin zeigt
- Bei Bedarf kann auch die Bezugspflege planen ein TP monatlich für einen geringen Zeitraum zuführen, dies sollte jedoch in einer FB für alle ersichtlich sein

Es sollte reichen ein Protokoll über 5 Tage zuführen, um die Problematik zuerkennen und die individuellen und fachlichen Maßnahmen ein zuleiten. Wenn nicht wird es natürlich länger geführt

Wann erfolgen Meldungen/ Informationen an den Arzt?

- Wenn die verordnete Trinkmenge über 3 Tage nicht erreicht wird
- Wenn die errechnete Trinkmenge im großen Ausmaß nicht erreicht wird (über einen Zeitraum von einer Woche) und/oder Anzeichen einer Dehydration entstehen
- Wenn sich das Trinkverhalten massiv verändert hat in kürzester Zeit
- Wenn Ein- und Ausfuhr Differenzen von mehr als 200ml betragen
- Eine Flüssigkeitsbilanzierung muss immer verordnet werden

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	5/5	Verw./MA